

TEMA 3.17 • OBSTETRICIA

Embarazo Ectópico — Casos Clínicos

PERFIL EUNACOM 2.01.2.013
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Embarazo Ectópico — Casos Clínicos

Casos Prácticos Tipo EUNACOM

TABLA 3.17.1: ECO TV VS BHCG				
ECO TV	BHCG	CLÍNICA ADICIONAL	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
Negativa	3.600 UI/L	FC 140 (inestable)	Ectópico roto	Cirugía urgente (laparoscopia/laparotomía)
Negativa	1.600 UI/L	Sin síntomas	Probable ectópico (< 3.500)	Metotrexato (< 5.000, sin latidos)
Negativa	8.000 UI/L	Sin síntomas	Ectópico no roto grande	Laparoscopia (MTX contraindicado: βHCG ≥ 5.000)
Negativa	500 UI/L	Sin síntomas	Incierto (puede ser embarazo normal pequeño)	Repetir βHCG + eco en 48h
Negativa	2.000 UI/L	Sin síntomas	Probabilidad intermedia	Repetir βHCG + eco en 48h

Interpretación de la βHCG en el seguimiento a 48h

Caso: βHCG basal 500 UI/L

TABLA 3.17.2: BHCG A 48H VS CÁLCULO			
BHCG A 48H	CÁLCULO	INTERPRETACIÓN	CONDUCTA
600	+20% (< 66%)	Probable ectópico	Metotrexato
1.000	+100% (≥ 66%)	Probable embarazo normal (muy pequeño aún)	Control → eco cuando βHCG ≥ 1.500–3.500

Reglas de Oro del Ectópico

PERLA CLÍNICA EUNACOM
- βHCG ≥ 3.500 sin embarazo intrauterino visible → **ectópico hasta que se demuestre lo contrario** - βHCG sube < 66% en 48h → **ectópico** - MTX contraindicado si βHCG ≥ **5.000** o latidos (+) - Hemodinamia inestable → **cirugía urgente**, no esperar confirmación - Embarazo intrauterino visible NO descarta ectópico → pensar en **heterotópico**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Mujer de 28 años con amenorrea de 7 semanas, beta-HCG de 2,500 mUI/mL, dolor en fosa ilíaca derecha y sangrado vaginal escaso. Ecografía TV: cavidad uterina vacía, imagen anexial derecha de 2.5 cm. ¿Conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Embarazo Ectópico — Casos Clínicos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS**
- Casos Prácticos Tipo EUNACOM
 - Interpretación de la βHCG en el seguimiento a 48h
 - Caso: βHCG basal 500 UI/L
 - Reglas de Oro del Ectópico
 - Repetir βHCG + eco en 48h
 - βHCG ≥ 3.500 sin embarazo intrauterino visible →
 - Embarazo intrauterino visible NO descarta ectópico → pensar en

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EMBARAZO ECTÓPICO — CASOS CLÍNICOS)

PREGUNTA 1

Mujer de 28 años con amenorrea de 7 semanas, beta-HCG de 2,500 mUI/mL, dolor en fosa ilíaca derecha y sangrado vaginal escaso. Ecografía TV: cavidad uterina vacía, imagen anexial derecha de 2.5 cm. ¿Conducta?

- A)** Legrado uterino por aborto incompleto
- B)** Metotrexato intramuscular — paciente hemodinámicamente estable con criterios
- C)** Esperar evolución espontánea (expectante)
- D)** Laparotomía de urgencia
- E)** Repetir beta-HCG en 48h y si dobla, hospitalizar

PREGUNTA 2

Mujer de 25 años con embarazo ectópico. Llega con PA 70/40 mmHg, FC 130 lpm, abdomen en tabla y dolor generalizado. ¿Conducta inmediata?

- A)** Metotrexato IM y observación 24h
- B)** Beta-HCG urgente para confirmar el diagnóstico
- C)** Laparoscopia/laparotomía de urgencia con reanimación simultánea
- D)** Transfusión de 2 unidades de GR y observar respuesta
- E)** Ecografía TV para confirmar localización antes de operar

PREGUNTA 3

¿Cuál es el factor de riesgo más importante para embarazo ectópico?

- A)** Multiparidad
- B)** Antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) o cirugía tubárica previa
- C)** Uso de anticonceptivos orales combinados
- D)** Nuliparidad
- E)** Síndrome de ovario poliquístico

RESUMEN: EMBARAZO ECTÓPICO — CASOS CLÍNICOS